

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

PAS · ESCALA DE PÁNICO Y AGORAFOBIA DE BANDELOW

Panic and Agoraphobia Scale – Evaluación multidimensional integral de ataques de pánico, conducta agorafóbica y deterioro funcional

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial	Panic and Agoraphobia Scale (PAS / Escala de Pánico y Agorafobia)
Autor Original	Borwin Bandelow (1995) - Universidad de Gotinga (Alemania)
Validación Española	Banco de Instrumentos de Bobes et al. (2004) y Grupo de Trabajo de Trastornos de Ansiedad
Tipo de Instrumento	Escala de evaluación clínica estructurada (versión heteroaplicada y autoinforme correlacionado)
Población Diana	Pacientes adolescentes y adultos (>= 16 años) con Trastorno de Pánico con o sin Agorafobia
Tiempo de Aplicación	8 a 12 minutos (13 reactivos estructurados)
Formato de Respuesta	Escala tipo Likert clínica de 5 puntos: 0 (Ninguno / Ausente) a 4 (Extremo / Totalmente incapacitante)
Finalidad Clínica	Cuantificación dimensional de la severidad del trastorno de pánico, perfilado de sus 5 componentes psicopatológicos y monitorización ultrasensible en ensayos farmacológicos y TCC

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

El Trastorno de Pánico no es un fenómeno clínico aislado a los paroxismos de angustia, sino un síndrome complejo que engloba un continuo de secuelas psicopatológicas interrelacionadas: el miedo paroxístico inicial dispara la ansiedad anticipatoria crónica ("miedo al miedo"), la cual motiva conductas de evitación espacial (agorafobia), provocando deterioro progresivo en el desempeño sociolaboral y una obsesión hipocondríaca continua centrada en la salud corporal.

Borwin Bandelow formuló la PAS para resolver la limitación de cuestionarios previos que medían únicamente la frecuencia de las crisis sin evaluar el impacto vital global. La escala se compone de 5 subescalas correlacionadas que cubren holísticamente el espectro nosológico del pánico: a) Ataques de Pánico, b) Agorafobia y Evitación, c) Ansiedad Anticipatoria, d) Discapacidad y Disfunción Familiar/Laboral, y e) Preocupaciones Hipocondríacas sobre la Salud.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Subescala PAS	Nº Ítems	Contenido Sintomático Evaluado
1. Ataques de Pánico	3 ítems	Ítem 1 Frecuencia semanal de crisis, Ítem 2 Severidad e intensidad de los síntomas físicos, Ítem 3 Duración del ataque pico.
2. Agorafobia / Evitación	3 ítems	Ítem 4 Frecuencia de evitación de lugares públicos/multitudes, Ítem 5 Severidad del miedo agorafóbico, Ítem 6 Dependencia de personas acompañantes.
3. Ansiedad Anticipatoria	2 ítems	Ítem 7 Frecuencia de la preocupación aprensiva por sufrir una crisis, Ítem 8 Severidad del desasosiego diario.
4. Discapacidad Funcional	3 ítems	Ítem 9 Deterioro en vida laboral/estudios, Ítem 10 Deterioro en vida social/ocio, Ítem 11 Deterioro familiar/pareja.
5. Preocupación por la Salud	2 ítems	Ítem 12 Convicción de padecer enfermedad orgánica no filiada, Ítem 13 Miedo a secuelas físicas/mentales irreparables.
Puntuación Total PAS	13 ítems	Suma directa de los 13 reactivos (Rango absoluto: 0 a 52 puntos).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · PAS

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

Consistencia Interna	Alfa de Cronbach global = 0.88 a 0.92 en muestras clínicas internacionales y de validación española (Bandelow, 1995; Bobes et al., 2004). Subescalas: entre 0.76 y 0.89.
Fiabilidad Inter-Jueces	Coeficiente de correlación intraclase ICC = 0.91 a 0.96 entre clínicos evaluadores; correlación entre heteroaplicada y autoinforme $r = 0.88$.
Validez Concurrente	Correlación sobresaliente con el Panic Disorder Severity Scale (PDSS, $r = 0.86$), con el Cuestionario de Agorafobia de Marks ($r = 0.82$) y con la HARS ($r = 0.74$).
Sensibilidad Terapéutica	Excelente sensibilidad para capturar la remisión diferencial inducida por ISRS (paroxetina, sertralina) y TCC (desensibilización en vivo y reestructuración interoceptiva).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- Calificación de Cada Ítem (0 a 4):** Cada reactivo se puntúa de 0 a 4 puntos según descripciones precisas:
 - 0 = Ninguno / Ausente; 1 = Leve; 2 = Moderado; 3 = Grave; 4 = Muy grave / Incapacitante total.
- Cálculo de Subtotales:**
 - Subescala 1 (Ataques):** Suma de ítems 1 a 3 (Rango: 0 a 12).
 - Subescala 2 (Agorafobia):** Suma de ítems 4 a 6 (Rango: 0 a 12).
 - Subescala 3 (Anticipatoria):** Suma de ítems 7 y 8 (Rango: 0 a 8).
 - Subescala 4 (Discapacidad):** Suma de ítems 9 a 11 (Rango: 0 a 12).
 - Subescala 5 (Preocupación Salud):** Suma de ítems 12 y 13 (Rango: 0 a 8).
- Puntuación Total PAS:** Suma directa de los 13 ítems (Rango: 0 a 52 puntos).

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación Total	Estratificación	Gravedad del Cuadro	Directriz Asistencial Recomendada
0 a 8 puntos	Remisión / Normal	Asintomático	Remisión clínica completa o pánico residual insignificante.
9 a 18 puntos	Pánico / Ágora Leve	Grado Menor	Psicoeducación, reentrenamiento respiratorio y seguimiento.
19 a 28 puntos	Trastorno Moderado	Afectación Funcional	Tratamiento farmacológico con ISRS y/o psicoterapia TCC.
29 a 39 puntos	Trastorno Grave	Marcada Invalidación	Manejo multimodal intensivo; exposición graduada en vivo.
40 a 52 puntos	Trastorno Muy Grave	Incapacitante Total	Confinamiento domiciliario agorafóbico; abordaje domiciliario o urgente.

CRITERIO OFICIAL DE REMISIÓN CLÍNICA (PAS ≤ 8): Bandelow (1995) fijó el umbral de remisión en una puntuación total menor o igual a 8 puntos. Una respuesta terapéutica favorable exige una reducción mínima del 50% respecto a la puntuación basal y ausencia de ataques de pánico mayores en la subescala 1.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · PAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Establecimiento de Línea de Base en PAS: Registrar las 5 dimensiones clínicas al inicio.

Paso 2: Intervención Dirigida por Subescala:

- **Si domina la Subescala 1 (Ataques frecuentes e intensos):** Iniciar tratamiento con ISRS (sertralina, escitalopram, paroxetina) para yugular la cascada biológica del pánico.
- **Si domina la Subescala 2 (Agorafobia y conductas de seguridad):** Priorizar Terapia Cognitivo-Conductual con jerarquía de exposición en vivo sin acompañante.
- **Si domina la Subescala 5 (Preocupaciones por la salud):** Realizar reestructuración cognitiva sobre las interpretaciones catastróficas somáticas (Clark).

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

Identificación: Mujer de 32 años, dependiente de comercio, acude a salud mental tras 8 meses sufriendo crisis paroxísticas de taquicardia y sensación de asfixia en el metro, habiendo abandonado el transporte público y necesitando que su pareja la acompañe a su puesto de trabajo.

Evaluación Psicométrica Inicial en PAS: Total = 33 / 52 puntos (Trastorno Grave).

- **Subescala 1 (Ataques):** 8 / 12 puntos. Registra 3 crisis completas a la semana (ítem 1 = 3), con sensación inminente de desmayo y muerte (ítem 2 = 3).
- **Subescala 2 (Agorafobia):** 10 / 12 puntos. Evita sistemáticamente metro, trenes, centros comerciales y ascensores (ítem 4 = 4) y sólo sale acompañada (ítem 6 = 3).
- **Subescala 3 (Anticipatoria):** 6 / 8 puntos. Estado constante de tensión vigilante esperando la próxima crisis (ítem 7 = 3).
- **Subescala 4 (Discapacidad):** 5 / 12 puntos. Amenaza de despido por retrasos diarios.
- **Subescala 5 (Salud):** 4 / 8 puntos. Convencida de padecer prolapso de la válvula mitral.

Intervención: Se instauró tratamiento con sertralina (titulada a 100 mg/día) y programa TCC de 12 sesiones de exposición gradual en vivo al metro y desmantelamiento de conductas de seguridad. A las 12 semanas, la puntuación total en la PAS se redujo a 6 puntos (remisión clínica completa), desplazándose la paciente en transporte público de forma autónoma.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTAS CRÍTICAS DE SEGURIDAD

- Descartar causas médicas orgánicas (síndrome coronario agudo, embolismo pulmonar, arritmias paroxísticas) en todo primer ataque de pánico.
- La automedicación reactiva con benzodiacepinas refuerza el condicionamiento agorafóbico al actuar como conducta de seguridad química.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- **Trastorno de Ansiedad Generalizada:** La preocupación es continua y flotante sobre problemas vitales, sin crisis paroxísticas agudas.
- **Fobia Social:** El temor agorafóbico en la PAS es a no recibir auxilio en caso de crisis, no a ser juzgado o evaluado por los demás.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Bandelow, B. (1995). Assessing the efficacy of treatments for panic disorder and agoraphobia: II. The Panic and Agoraphobia Scale. *International Clinical Psychopharmacology*, 10(2), 73–82.
- Bandelow, B. (1999). *Panic and Agoraphobia Scale (PAS): User's manual*. Hogrefe & Huber Publishers.
- Bobes, J., García-Portilla, M. P., Bascarán, M. T., Sáiz, P. A., & Bousoño, M. (2004). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica* (3.ª ed.). Ars Médica.
- Clark, D. M. (1986). A cognitive approach to panic. *Behaviour Research and Therapy*, 24(4), 461–470.